EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 91519
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-28 09:27:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ANGEL MAXIMILIANO LAGOS LAGOS			RUN	: 4.382.105-9
F.Nac	: 18-06-2022	Edad	: 2 AÑOS, 2 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-27	Fecha Egreso	: 2024-08-28 09:27:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) IC compensada
2) EPOC sobreinfectado???
3) HTA
4) DM2
5) FA en TACO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Familiar de paciente refiere inicio de sintomatología hace 5 días aproximadamente, presentando aumento de disnea basal, asociado a aumento de volumen en EEII, escasos accesos de tos con expectoración blanquecina/transparente, sin algún otro signo o síntoma asociado. Niega fiebre, nauseas, vómitos, etc.
Destaca episodios de mareos y síncope de larga data, gatillados con la deambulación. Además, cuadro de 5 días sin defecaciones asociado a distensión abdominal.
Ingresa a SU desaturando, con compromiso ventilatorio.
Familiar menciona cese de uso hace 1 semana de terapia complementaria para HTA: Padeval 2.5mg debido a falta de stock a nivel nacional.
Exámenes de laboratorio de ingreso reportan: Gli: 166 | PT: 6,8 | Alb: 3,9 | Crea: 1,50 | CK MB: 19 | CK: 173 | Clearance Calculado (MDRD): 44,69 | % CK-MB: 11,0 | PCR: 201,5 | Uremia: 61 | Na: 140,00 | K: 4,10 | Cl: 99,00 | Hb: 12,3 | HTO: 36,5 | GB: 11,00 | Plaq: 200 | Segmentados: 67 | Linfocitos: 21 | Monocitos: 10 | Eosinófilos: 1 | Basófilos: 1 | INR: 1,27 | Tiempo de Protrombina %: 71 | Tiempo de Protrombina seg: 16,6 | Troponina: 159,4 .
Control: Gli: 141 | Crea: 1,30 | Clearance Calculado (MDRD): 54,11 | PCR: 33,6 | Uremia: 39 | Na: 138,00 | K: 4,50 | Cl: 100,00 | Hb: 11,5 | HTO: 35,2 | GB: 8,80 | Plaq: 175 | Segmentados: 65 | Linfocitos: 17 | Monocitos: 11 | Eosinófilos: 6 | Basófilos: 1 | VHS: 64 | INR: 1,47 | Tiempo de Protrombina %: 58 | Tiempo de Protrombina seg: 19,1 | TTPA: 44.

Se evalúa Parámetros inflamatorios elevados. En control posterior con descenso franco. Recibiendo terapia con ceftriaxona hoy 4 dias . Hemocultivos Negativos a la fecha.
Evolucionando favorablemente sin requerimiento de oxigeno por mas de 24 horas, normocardico, normotenso, sat 94% con fio2 21%

Ex fisico -> Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs, sin uso de musculatura accesorio,, yugulares planas, Cardiaco RR2T NAS, Pulmonar MP (+), estertores finos bibasales, Extremiades sin edema, sin signos de TVP.
En condiciones de alta con HODOM.

PLAN DE MANEJO:

Alta Medica
Continuar Manejo Por HODOM
Control SOS Urgencia

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen diabetico hiposodico a tolerancia | Restricción hídrica 800cc día
2. Ceftriaxona 2 gr al dia EV POR 6 DIAS
3. Furosemida 20 mg c/12 hrs VO
4. Espironolactoma 25 mg c/24 hrs VO
5. Omeprazol 20 mg al dia VO
6. Atorvastatina 20 mg al dia VO
7. Losartan 50 mg c/12 hrs VO
8. Bisoprolol 2,5 mg al dia VO
9. Bromuro de ipatropio 2 puff c/6hrs por AC
10. Brexotide 2 puff c/12 hrs por AC
11. Pregabalina 75mg vo dia
12. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS
13. Insulina NPH 28 UI AM - 24 UI PM SC
14. KNT R + MPOR 2 VECES
15. Apixaban 2,5 mg c/12 hrs VO
16. Pavedal 2,5 mg VO
17. Tiotropio un puff al dia
18. Rescatar HC
19. Control exámenes de laboratorio en 48 horas
20. Avisar eventualidad

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO